

Approche ROP – Fatigue post-mononucléose et point de côté gauche

Cas clinique, lecture anatomo-fonctionnelle et stratégie de prise en charge

1. Cas clinique



- Adolescent, 17 ans
- Mononucléose récente
- Fatigue intense, récupération lente
- Sensation de « corps sans ressort »
- Point de côté gauche à l'effort
- Difficulté à reprendre le sport



Symptôme pivot : douleur sourde sous les dernières côtes gauches, majorée par l'effort et la respiration profonde.

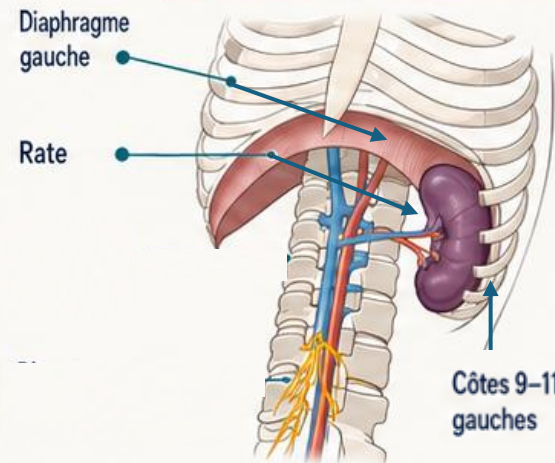
2. Prudence / diagnostic d'exclusion

- ⚠ Rate fragile, molle, très vascularisée
- ⚠ Toujours exclure une splénomégalie
- ⚠ Vérifier absence de douleur d'épaule gauche, malaise, pâleur
- ⚠ Réorienter si fièvre persistante, pétéchies ou ganglions inquiétants
- ⚠ Éviter sports de contact et charges lourdes



État émotionnel : découragement, appréhension face à la reprise.

3. Analyse anatomo-fonctionnelle ROP



Environnement fonctionnel de la rate : la rate suit les mouvements du diaphragme via ses attaches.



Étage neuro-végétatif Th6–Th9 : lien sympathique via le plexus coeliaque.



Rôle du système porte : la circulation splénique dépend aussi de l'environnement hépatique.

4. Protocole de traitement ROP

Séquence thérapeutique

1 Syndrome général d'adaptation



MRP, diencephale, hypophyse, nerf vague.

2 Étage neuro-végétatif



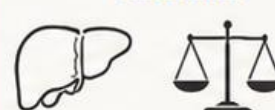
Th6–Th9, articulations costo-transversaires, plexus coeliaque.

3 Libération loco-régionale



Diaphragme gauche, angle splénique du côlon, estomac, rein gauche.

4 Drainage et intégration émotionnelle



Foie / système porte, balance "cerveau limbique-rate".

5. Conseils et suivi



Reprise progressive et fractionnée



Éviter effort intense tant que la récupération n'est pas stabilisée



Auto-observation sur 3 semaines : énergie, sommeil, tolérance à l'effort



La ROP accompagne un terrain fonctionnel. Elle ne remplace ni le diagnostic médical ni la prise en charge d'une complication splénique.